研修医・専攻医・30分

デジタル時代のナラティブ・メディスン

物語の力 × 臨床思考 × デジタルツールの統合

参考文献

2026-03-21 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

導入の問い

あなたが最近診た患者さんの中で、病歴だけでは捉えきれなかった”何か”を感じた経験はありますか？

今日のゴール

この30分の後、あなたは：

- ナラティブ・メディスンの理論的背景を **説明できる**（理解）
- デジタル・ナラティブの可能性と限界を **論じられる**（分析）
- 統合的アプローチを1つ **導入する計画を立てられる**（創造）

ナラティブ・メディスンとは

- 提唱者: Rita Charon（コロンビア大学, 2001）
- 定義: 患者の物語を受け止め、共に意味を紡ぐ臨床態度
- 従来の「科学的医学」への批判ではなく **補完**
- 共感・省察・専門職性・信頼を育む枠組み

Charonの3要素

要素	意味	臨床での実践
Attention	注意深く聴く	患者の語りに意識を向ける
Representation	物語を表現する	聴いたことを言語化・記録する
Affiliation	繋がりを形成する	治療的関係を深める

現状の課題

Frontiers in Medicine（2026, ミニレビュー）が挙げる3つの障壁：

- カリキュラム過密 → 時間確保が困難
- 教員の準備不足と組織的支援の不足 → 教え方が体系化されていない
- 標準化・検証済みの評価枠組みの欠如 → 能力測定が未解決

形骸化リスクへの警鐘

ナラティブ教育は「良いこと」として導入されがち
だが、構造的な障壁を無視すると形骸化する

デジタルが拡張する方向

JMIR（2026, 概説記事）が取り上げる3つの応用領域：

- ① 医学教育への応用
- ② 臨床での活用
- ③ 社会的に疎外された人々への応用

① 医学教育への応用

- 患者・家族・介護者の語りを映像などで教材化し、共感やコミュニケーション、専門職としてのあり方を育てる
- 研修医の振り返りの文章を電子ポートフォリオに残し、指導者が評価する
- 例: 双極症の当事者を撮影した映像を見た精神科研修医が、共感や思いやりの高まりを自己報告（効果の客観的な測定ではない）

② 臨床での活用

- 患者の心理・感情・社会・スピリチュアルな体験の語りを診療記録に残し、チームで共有できる
- 記録された語りをAIで分析する可能性
- 例: 緩和ケアの再設計で、患者・家族の委員会を最初から関与させた

③ 疎外された人々への応用と課題

応用例：

- 若者・先住民・精神疾患や物質使用の当事者など、声が届きにくい人々の語りを増幅する
- AIで語りを研修用のシミュレーション場面や臨床判断支援につなげる

課題（JMIR 論考が挙げるもの）：

- 研究・カリキュラム・診療を計画・評価する新しい方法論が必要
- 語り手や家族の同意と、語りの使われ方をめぐる倫理

ナラティブ × 臨床思考の統合

BMC Medical Education（2026）— 神経内科の臨床実習での比較研究：

- 方法: 臨床医学実習生100名（2クラス・各50名）を、ナラティブ ＋ 臨床思考モデル統合教育群と従来教育群に分けて比較（山東第一医科大学・脳梗塞の章・単施設）
- 結果: 統合群で、筆記試験・症例分析の得点、患者満足度、SEGUE による医師患者間コミュニケーションが有意に高かった（$p < 0.05$）
- 含意: ナラティブと臨床思考は **相補的でありうる**（著者は「さらなる検討が必要」としている）

統合モデルの流れ


患者の物語（ナラティブ）
Attention（注意深く聴く）
物語の構造化
Representation
臨床思考モデル適用
仮説生成
パターン認識
Affiliation（関係性の深化）
統合的臨床判断

批判的吟味のポイント

- Study Designの妥当性(単施設 vs 多施設、サンプルサイズ)
- 「学習成果」の定義と測定方法は適切か
- 神経内科以外への一般化可能性
- 教育者のトレーニング効果の交絡

ペアディスカッション

２人1組で4分：

あなたの臨床現場で、ナラティブ × 臨床思考 × デジタルツールの統合を1つ実践するとしたら何ができるか

考えるヒント

- 外来の問診にナラティブ要素を1つ追加するなら
- カンファで「患者の物語」を構造的に共有する方法
- 音声記録やテンプレートをどう使えるか

全体共有

- 2〜3ペアに発表してもらう（2分）
- ファシリテーターは具体的なアクションレベルに落とすフィードバック
- 「やれそう」と「やりたい」が交差する点を拾う

3つの論文が示す全体像

論文	視点	臨床への含意
Frontiers	理想と障壁	制約を知った上で設計する
JMIR	デジタルの応用例（概説）	障壁への対応を考える手がかり
BMC	統合教育の比較研究（単施設）	「物語＋構造」が有効でありうることを示す一例

理解度確認

3つの論文を踏まえて、ナラティブ教育の最大のレバレッジポイントはどこだと思いますか

来週までの1アクション

次回のカンファまでに1つ試す：

- [ ] 患者の語りに3分間、中断せず耳を傾ける
- [ ] カルテの「現病歴」に患者の言葉を1文そのまま残す
- [ ] 同僚と「心に残った患者の物語」を1つ共有する

まとめ

持ち帰りの問い

デジタルツールがナラティブの「記録」を便利にする一方で、聴く力そのものはテクノロジーでは代替できない

では、デジタル時代に「聴く力」をどう育むか

参考文献

1. JMIR (2026) — Digital Narrative Medicine: Translating Stories Into Medical Education and Better Patient Care (Sage CM. J Med Internet Res 2026;28:e93037). https://www.jmir.org/2026/1/e93037/
2. Frontiers in Medicine (2026) — Reimagining medical education: integrating medical humanism and narrative medicine into a new educational paradigm (Hou J, Chen J, Guo H. Mini Review). https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2026.1761177/full
3. BMC Medical Education (2026) — Application of narrative medicine combined with clinical thinking model in neurology teaching (Cui et al.). https://link.springer.com/article/10.1186/s12909-025-08492-x
4. Charon, R. (2001). Narrative Medicine: A Model for Empathy, Reflection, Profession, and Trust. JAMA, 286(15), 1897-1902.
5. PMC — Digital Narrative Medicine (Full Text). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12923091/

参考文献